

Управленческое резюме (5-7 стр.)

Чистяков Е. В.

22.08.2026

- [Управленческое резюме](#)
 - [1. Проблема](#)
 - [2. Что предлагается](#)
 - [3. Что не предлагается \(риски и границы\)](#)
 - [4. Необходимые документы \(комплект для учредителя и проверяющего\)](#)
 - [5. Пилот 90 дней \(минимальный безопасный старт\)](#)
 - [Три фазы](#)
 - [5 групп показателей](#)
 - [6 стоп-критериев](#)
 - [Решение по результатам](#)
 - [6. Пять действий в первый понедельник \(до обеда\)](#)
 - [7. Пять групп показателей пилота \(операционные определения\)](#)
 - [Группа 1. Заполненность пищевых карт](#)
 - [Группа 2. Доступный выбор](#)
 - [Группа 3. Исполнение](#)
 - [Группа 4. Отходы](#)
 - [Группа 5. События риска](#)
 - [8. Шесть возражений и честные ответы](#)
 - [9. Решение, которое требуется от руководителя](#)
 - [10. Контакт и обратная связь](#)

Управленческое резюме

Документ: краткая версия для директора учреждения и представителя учредителя.
Версия: 22.08.2026. **Объём:** 7 страниц А4 (≈ 2 500–4 000 слов). **Аудитория:** директор ПНИ/ДСО, заместитель по АХЧ, представитель учредителя. **Назначение:** первая точка входа для управленца, не прочитавшего 78 000-словный доклад. **Правовая сверка:** 22.08.2026. **Фактчекинг:** 22.08.2026. **Изменения после этой даты требуют перепроверки.**

***Главное правило.** Вариативное питание — не ресторан, не два полноценных меню и не безусловное исполнение любого желания. Это управляемая система, в которой безопасность имеет приоритет, медицинскую рамку определяет уполномоченный специалист, внутри допустимой рамки человеку предоставляют понятный выбор, выбор документируется, кухня исполняет назначение, но не ставит диагноз, результаты пилота измеряются, достоинство не противопоставляется безопасности. «% выбравших» — не KPI. Успех — доступность и исполнение осмысленного выбора, а не доля «выбравших».*

1. Проблема

Средний по России психоневрологический интернат — **289 коек** (расчёт проекта «Если быть точным» 2024, на основе данных Федерального казначейства; tochno.st). На обеде — поточная линия с одним вариантом каждого блюда. Двенадцать жителей из ста двадцати едят только с помощью; четыре сиделки — одна развозит лекарства. **Один обед — пять конфликтов:**

1. **Очередь против помощи.** Самостоятельные сидят перед остывающими тарелками — им первым, потому что быстрее. Кормимые ждут: 4 сиделки на 12 — это 3 цикла по 15–20 минут.
2. **«Он опять не ест кашу».** Журнала отказов нет, и врач узнает об отказах на обходе в четверг. Возможная депрессия, возможная начальная дисфагия — проверить некому.
3. **Лекарства и кофе.** Житель на клозапине с утра выпил две большие кружки крепкого кофе, который принесли родственники. **Кофеин в дозе 400–1000 мг/день повышает АУС клозапина в среднем на 19 %** (Hägg S. et al., Br J Clin Pharmacol 2000;49(1):59-63; 12 здоровых некурящих мужчин-добровольцев, однократная доза).
4. **Добавка.** Житель на оланзапине набрал 14 кг за год — оланзапин имеет один из самых выраженных весогенных профилей (**36,9 % пациентов с прибавкой ≥ 7 % веса за 38 нед.**, Campforts B. et al., BJPsych Open 2023;9(1):e18). Сиделка отказывается «вам нельзя, вы полнеете». Врачебного назначения нет.
5. **Проверка на следующей неделе.** Суточные пробы за двое суток будут подписаны сегодня. Документальная имитация контроля.

Почему все пять конфликтов — одна система. Каждый из пяти имеет отдельного «виноватого» в глазах участников: медленную сиделку, капризного жителя, неведущую семью, несдержанного соседа, нерадивого завхоза. И каждый на самом деле является отказом системы. Ни один из пяти не требует денег для начала. Три из пяти упираются в кадровую нагрузку. Вариативное питание добавит шестой конфликт — «кто выбирает блюдо». Если пять базовых не закрыты, шестой добьёт систему.

Три цифры, которые заставляют задуматься.

- **В изученных клинических группах на антипсихотиках дисфагия — 21,9–69,5 %** (Miarons Font M, Rofes Salsench L. Eur J Gastroenterol Hepatol 2017;29(12):1332-9; систематический обзор 18 исследований). **Популяции не совпадают с российскими ДСО; в вашем учреждении цифра может быть любой** — посчитайте свою в первые 10 дней пилота.
- **Смертность от пневмонии при шизофрении в 7 раз выше популяционной** (Correll C.U. et al., World Psychiatry 2022;21(2):248-271; мета-анализ 135 когорт 1957–2021; RR 7,00; 95 % ДИ 6,79–7,23). Аспирация — один из ключевых механизмов разрыва продолжительности жизни (15–20 лет).
- **99 % недееспособных жителей ПНИ находятся под опекой самого учреждения** — 117 000 чел. (проект «Если быть точным» 2024, на основе открытых данных Минтруда, Росстата, Федерального казначейства; tochno.st, 09.04.2026). **Это не уникальный риск Серафимовского — это общероссийская норма.** Учреждение одновременно опекун и поставщик услуг.

2. Что предлагается

Не «внедрение нового меню». Замер. 30 дней замер → 30 дней документы и обучение → 30 дней пилот. **Пилот 90 дней на одном отделении без новой сметы.** Один обед, одно

отделение, одна неделя замера. Лучше «сложное» отделение — с группой помощи, неговорящими жителями. Если получится у них — получится у всех.

Что не предлагается.

- **Не предлагается** менять меню целиком, убирать действующие нормативы, увеличивать смету, нанимать новых сотрудников.
- **Не предлагается** делать «шведский стол», «ресторанный день» или «два полноценных меню».
- **Не предлагается** считать «% выбравших» ключевым показателем.
- **Не предлагается** выдавать кухне функции врача: текстуры, лечебные столы, сдвиг времени еды у инсулинозависимых, длительный отказ, лечебное питание — зона врача.
- **Не предлагается** внедрять пилот без согласования с учредителем.

Граница 4.0 (что кухня не назначает). Без врача: любые ограничения рациона, изменение текстур, правила при дисфагии, протокол свободной воды, действия при длительном отказе, режим при седации, энтеральное/зондовое питание, комфортное кормление, сдвиг времени еды у инсулинозависимых, слабительные, назначение анализов и микронутриентов, интерпретация MUST, витаминизация. Без учредителя: изменение финансирования продуктовой строки, штатного расписания, аутсорсинг, официальный статус пилота. Без правовой проверки: формулировки о согласии недееспособного, обработка пищевых карт как персональных данных, ответы на запросы прокуратуры, конструкции «учреждение = опекун». **Таблица «лекарство × еда» на посту законна только с подписью врача.**

3. Что не предлагается (риски и границы)

Источник риска	Что мы НЕ предлагаем	Что мы предлагаем
Безопасность	Усиливать приём клозапина без оценки врача	Таблицу врача «лекарство × еда» на посту
Безопасность	Диагностировать дисфагию на кухне	Список риска и направление к врачу
Безопасность	Загущать жидкости «на всякий случай»	Назначение текстуры врачом с пересмотром
Безопасность	Запрещать кофе жителям на клозапине	Оценку врача и документированное решение
Право	Утверждать, что «запрета нет»	Комплект документов, разрешающий у вас
Право	Заявлять, что «74 % — статистика Минтруда»	«74 % — данные проекта «Если быть точным» за 2024 г., не официальная статистика Минтруда; в вашем доме цифра будет другой»
Право	Выдавать локальный приказ Серафимовского за общероссийскую норму	«Локальный приказ № 124 — правила внутреннего распорядка Серафимовского, не руководство к действию для других ДСО»
Финансы	Утверждать, что «вариативность почти	«Семидневный замер отходов и трудозатрат до старта — единственный способ получить

Источник риска	Что мы НЕ предлагаем	Что мы предлагаем
	бесплатна»	свою цифру»
Метод	Считать «% выбравших» KPI	Измерять доступность выбора и исполнение заказа
Метод	Называть единичный пример «лучшей практикой»	Пилот как измеримую гипотезу с 6 стоп-критериями

4. Необходимые документы (комплект для учредителя и проверяющего)

№	Документ	Назначение	Готовность
1	Локальное «Положение об организации питания»	Описывает модель выбора	Шаблон в проект/appendices/
2	Меню с вариантами	Циклограмма с двумя вариантами	Разрабатывается диетсестрой
3	Журнал заказа блюд	Документирует выбор	Форма в приложении 4
4	Журнал замен	Документирует пары эквивалентов	Форма в приложении 10
5	Пищевые карты жителей	Текстура, ограничения, воля	Форма в приложении 3
6	Согласование с учредителем	Уведомительный порядок	Шаблон письма
7	Приказ о рабочей группе	5 фамилий + срок	Шаблон в приложении
8	Письмо-уведомление учредителю	1 страница с обоснованием	Шаблон в приложении 32
9	Таблица врача «лекарство × еда»	На посту, подписана врачом	Разрабатывается врачом
10	Список риска дисфагии	На посту, подписан врачом	Разрабатывается врачом
11	Протокол пищевой безопасности	Пробы, бракераж, температуры	Формы в приложениях 5–6
12	Журнал обучения смены	8 часов на сотрудника за 90 дней	Шаблон в приложении

Итого 12 документов. Без комплекта та же практика выглядит как отступление от раскладки. С комплектом — как управленческое решение.

5. Пилот 90 дней (минимальный безопасный старт)

Три фазы

Фаза	Дни	Что делается	Что не делается
1. Замер	1–30	Сырьевая строка, отходы, остатки, ночной интервал, 5 чисел контингента, таблица врача	Не менять меню, не выбирать модель, не выпускать пресс-релиз
2. Документы	31–60	Положение, согласование, пары эквивалентов, обучение, журналы	Не масштабировать, не менять закупку
3. Пилот	61–90	Запуск выбора, ежедневный сбор данных, промежуточный контроль на 75-й день	Не вводить новые ставки

5 групп показателей

- 1. Заполненность пищевых карт** (доля жителей с заполненной картой, целевой диапазон 70–100 %).
- 2. Доля приёмов с реально доступным выбором** (целевой диапазон 80–100 %; **не % выбравших**).
- 3. Доля корректно исполненных заказов** (целевой диапазон 85–100 %; важен тренд).
- 4. Отказы, замены и пищевые отходы** (тарелочные остатки, кухонные отходы, замены по таблице пар; целевой диапазон — снижение относительно базового замера).
- 5. События риска** (пневмонии, падения, инциденты, гиперфагия, отказы ≥3 дней, обезвоживание; целевой — отсутствие роста).

Полный словарь 26 показателей — [09_инструменты/словарь_показателей.csv](#).

6 стоп-критериев

- Рост пневмоний ≥30 % по сравнению с предыдущим кварталом.
- Падение со смертельным исходом в столовой.
- Жалоба в прокуратуру.
- Приказ учредителя.
- Отзыв согласия учредителя.
- Отсутствие врача.

Решение по результатам

4–5 из 5 групп в норме	Масштабирование на 1–2 отделения
3 из 5	Корректировка пар, повторный пилот 60 дней
2 и меньше	Остановка, анализ причин

6. Пять действий в первый понедельник (до обеда)

- 1. Посчитать сырьевую строку** (1 час, калькулятор). Расходы на продукты за последний полный месяц ÷ число жителей ÷ число дней. Записать своё число. Если за пять минут никто не называет — это первая находка аудита.
- 2. Запустить семидневный замер отходов и времени раздачи** (10 минут на запуск). Ответственный — завпроизводства или старшая смена. Замерять: тарелочные

остатки по трём основным приёмам (г/порцию); кухонные остатки; время от начала раздачи до последней тарелки. Журнал — приложение 25.

3. **Приказ о рабочей группе** (30 минут). Директор или зам по АХЧ, врач или фельдшер, диетсестра или завпроизводства, старшая медсестра одного отделения, представитель учредителя — если получится. Пункт: «в срок до [дата + 30 дней] подготовить предложение по пилоту на одном отделении на 90 дней».
4. **Письмо-уведомление учредителю** (30 минут). Одна страница: обоснование (Новосибирская и Иркутская области, СПб), ссылка на СанПиН 3590-20 п. 7.1.11 / 4282-26 п. 56(11), сроки, просьба о согласовании. Шаблон — приложение 32; разделы 31, 38.
5. **Точка пилота** (1 час с заведованием). Одно отделение 20–35 жителей; лучше «сложное» (группа помощи, неговорящие), не самое удобное; одна смена; один приём пищи — обед.

Через 7 дней на руках: сырьевая строка, замер отходов запущен, приказ с пятью фамилиями, письмо учредителю, выбранное отделение.

7. Пять групп показателей пилота (операционные определения)

Группа 1. Заполненность пищевых карт

Поле	Числитель	Знаменатель	Источник	Периодичность	Ответственный
Р-1 Пищевые карты заполнены	Число жителей с заполненной картой	Общее число жителей в отделении	Пищевые карты	1 раз в 30 дней	Старшая медсестра
Р-2 Карты с датой пересмотра текстуры	Число жителей с актуальной датой	Жители с назначенной текстурой	Пищевые карты	1 раз в 30 дней	Врач
Р-3 Список риска дисфагии актуализирован	С актуальной отметкой	Всего в списке	Пищевые карты + журнал 6 признаков	1 раз в 30 дней	Врач + старшая медсестра

Группа 2. Доступный выбор

Поле	Числитель	Знаменатель	Источник	Периодичность	Ответственный
Р-4 Приёмы с реально доступным выбором	Обеды с 2 вариантами	Всего обедов	Журнал заказа	Ежедневно	Старшая смены
Р-5 Жители получившие выбор ≥1 раз	Жители с предложенным выбором	Всего жителей	Журнал заказа	1 раз в 30 дней	Старшая смены
Р-6 Пар эквивалентов заявлено	Утверждённых врачом	Не менее 3	Протокол рабочей группы	1 раз в 30 дней	Диетсестра + врач

Группа 3. Исполнение

Поле	Числитель	Знаменатель	Источник	Периодичность	Ответственный
Р-7 Заказы исполненные точно	Точно по журналу	Всего заказов	Журнал заказа + акт приёма	Ежедневно	Завпроизводства
Р-8 Заказы с правильной текстурой	С соответствующей назначению	С назначенной текстурой	Журнал заказа + журнал текстур	Ежедневно	Завпроизводства
Р-9 Заказы с учётом лекарств	С пометкой об ограничениях	С назначениями	Журнал заказа + таблица врача	Ежедневно	Старшая смены

Группа 4. Отходы

Поле	Числитель	Знаменатель	Источник	Периодичность	Ответственный
Р-10 Тарелочные остатки средние	Сумма остатков	Приёмы × жители	Журнал остатков	Ежедневно	Старшая смены
Р-11 Приёмы с отказом ≥50 %	С остатком ≥50 %	Всего приёмов	Журнал остатков	Ежедневно	Старшая смены
Р-12 Кухонные остатки	Масса отходов кухни	Жители × дни	Журнал отходов	Ежедневно	Завпроизводства
Р-13 Замены по таблице пар	Замен	Всего заказов	Журнал замен	Ежедневно	Старшая смены
Р-14 Возвраты из зала	Возвращённых блюд	Поданных	Журнал возвратов	Ежедневно	Старшая смены

Группа 5. События риска

Поле	Числитель	Знаменатель	Источник	Периодичность	Ответственный
Р-15 Пневмонии за период	Диагностированных	Жители × дни	Меддокументация	1 раз в 30 дней	Врач
Р-16 Падения в столовой	Падений	—	Журнал инцидентов	Ежедневно	Старшая смены
Р-17 Инциденты за столом	Агрессивных	—	Журнал инцидентов	Ежедневно	Старшая смены

Поле	Числитель	Знаменатель	Источник	Периодичность	Ответственный
P-18 Гиперфагические эпизоды	Эпизодов переедания	—	Журнал смены	Ежедневно	Врач + смена
P-19 Отказы от еды ≥3 дней	Случаев	—	Журнал отказов	Ежедневно	Врач
P-20 Случаи обезвоживания	Случаев	—	Меддокументация	1 раз в 30 дней	Врач

Риск интерпретации: «100 % карт заполнены» ≠ «100 % правильно заполнены». «100 % заказов исполнено» — это не цель, а тренд. Абсолютные 100 % редки; цель — снижение числа ошибок.

8. Шесть возражений и честные ответы

1. **«Закон не запрещает, но и не обязывает. Зачем нам это?»** — Затем, что **ответ проверяющему — комплект документов, не формула «запрета нет»**. Положение, меню с вариантами, журнал заказа, журнал замен, пищевые карты, согласование с учредителем. Без комплекта та же практика выглядит как отступление от раскладки.
2. **«Клоzapин и кофе — это к нам не относится».** — У вас есть жители на антипсихотиках. **76,3 % прибавка веса на клоzapине за 38 нед** (Campforts 2023, 202 исследования). Это не все, но это риск. Одна подписанная таблица на посту — таблица «лекарство × еда» — закрывает тему.
3. **«99 % под опекой учреждения — конфликт интересов».** — Да, и это **не уникальный риск, а общероссийская норма**. Закон 3185-1 ст. 5 ч. 2 говорит о праве на гуманное отношение. **Этот текст работает и тогда, когда опекун и поставщик совпадают**. Решение — задокументированный процесс выражения воли.
4. **«СанПин меняется через 6 дней, мы не успеем».** — Успеете. **СанПин 2.3/2.4.4282-26 вступает в силу с 01.09.2026** (пост. ГГСВ РФ от 02.06.2026 № 18, рег. Минюст 02.06.2026 № 86854; действует до 01.09.2032). Главное для учреждений соцобслуживания — п. 56 подп. 11. Формулировка «не менее трёх приёмов + диетическое по показаниям» сохранена в обеих редакциях. Смотрите новую редакцию с 1 сентября.
5. **«У нас 1000 коек, пилот на отделении — капля в море».** — Пилот на 20–35 жителях — это не капля, а **доказательство работоспособности модели в вашем учреждении**. Масштабирование — после 90 дней успеха. **Внедрено публично ≠ доказанный эффект**. Панелей «до/после» в открытом доступе почти нет.
6. **«Зачем считать “% выбравших”, если это не KPI?»** — Потому что **успех пилота — доступность и исполнение осмысленного выбора**, а не доля «выбравших». Человек вправе выбрать стандартный вариант или не выбирать вовсе. **«Нет выбора» — это тоже результат**, и не худший: он говорит, что человек удовлетворён стандартом.

9. Решение, которое требуется от руководителя

Одна подпись, одно решение.

Что подписать	Когда	Зачем
Приказ о рабочей группе (5 фамилий)	Понедельник	Запустить ФАЗУ 1
Письмо-уведомление учредителю	Понедельник–вторник	Закрыть риск «самоуправство»
Локальное «Положение об организации питания»	День 31	Зафиксировать модель
Согласование пилота с учредителем	День 33	Получить письменное «да»
Утверждение отчёта 3 (90 дней)	День 90	Решение о корректировке или масштабировании

Одна мысль, которую нужно унести. «Не внедряйте вслепую. Измеряйте». Семь дней замера отделяют убеждение от знания.

Одна просьба к 26.08. Не меняйте всё меню. Один обед, одно отделение, одна неделя замера. **Право выбора становится реальным тогда, когда его можно проследить до тарелки.**

10. Контакт и обратная связь

Автор: Чистяков Евгений Владимирович, директор СПб ГАСУСОН «ДСО „Серафимовский“». **Адрес:** 198320, Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Красногородская, д. 1. **Сайт (архив):** web.archive.org/web/20260415001233 (актуальный адрес недоступен с 21.08.2026). **Дата правовой сверки:** 22.08.2026. **Дата фактчекинга:** 22.08.2026. **Дата актуальности нормативов:** до 31.08.2026 (СанПиН 3590-20) / с 01.09.2026 (СанПиН 4282-26).

Дисклеймер. Материал носит информационный и методический характер и не заменяет индивидуального юридического заключения, клинической рекомендации или финансового расчёта. Шаблоны — проекты локальных форм; требуют адаптации к конкретному учреждению. Все цифры и нормативные ссылки проверены на 22.08.2026; после этой даты конкретный акт мог измениться. После 01.09.2026 — действует СанПиН 2.3/2.4.4282-26 (п. 56 подп. 11).

Дата: 22.08.2026. **Версия:** 1.0. **Семинар:** «Пространство Новых Идей 2.0», 25–27 августа 2026 года, Санкт-Петербург, Минтруд России. **Сессия:** 26.08.2026, 14:00–15:30, площадка № 2 — ДСО «Тесовый берег».